

Factores de riesgo modificables (tabaco, alcohol, obesidad, sedentarismo)

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

Las **enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)** son actualmente la **principal causa de muerte y discapacidad en Chile**, representando más del **80 % de la mortalidad nacional**. Estas incluyen la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia, obesidad, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Su desarrollo está fuertemente condicionado por **factores de riesgo modificables**: el **tabaquismo**, el **consumo nocivo de alcohol**, la **mala alimentación** y el **sedentarismo**.

La comprensión y manejo de estos factores es central para el médico general, ya que su intervención en APS permite **prevenir la mayor parte de las muertes prematuras** y mejorar la calidad de vida poblacional.

En el **EUNACOM**, este tema integra los conocimientos de **epidemiología, promoción y prevención**, y mide la capacidad del futuro médico para **reconocer y actuar sobre los determinantes conductuales de la salud** con base en políticas públicas nacionales.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición

“Los factores de riesgo modificables son condiciones o comportamientos que aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad, pero que pueden cambiarse o controlarse mediante intervenciones de salud o acciones personales.”
(OMS, 2018)

2.2. Clasificación

- **Conductuales:** tabaco, alcohol, inactividad física, dieta no saludable.
- **Metabólicos:** hipertensión, dislipidemia, hiperglicemia, obesidad abdominal.
- **Sociales:** bajo nivel educativo, pobreza, estrés laboral, inequidad de género.

Los factores conductuales y sociales se entrelazan, perpetuando un círculo de riesgo que comienza en la infancia y se mantiene en la adultez.

3. Situación epidemiológica en Chile

Según la **Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016–2017**:

- **74,2 %** de la población adulta presenta **sobrepeso u obesidad**.
- **86,7 %** es **sedentaria** según criterios OMS.
- **33,3 %** fuma actualmente.
- **11,7 %** presenta **consumo riesgoso de alcohol**.
- El **24 %** de la mortalidad total se atribuye al **tabaquismo** (DEIS 2021).

Estos datos reflejan una **epidemia de factores de riesgo** que amenaza la sostenibilidad del sistema sanitario y la equidad en salud.

4. Tabaco

4.1. Relevancia

El tabaco es la **principal causa prevenible de muerte en Chile**, responsable de unas **16.000 muertes anuales** (DEIS, 2022).

4.2. Efectos fisiopatológicos

- Aumenta radicales libres y estrés oxidativo → daño endotelial.
- Promueve aterosclerosis, cáncer, EPOC y enfermedad cardiovascular.
- Reduce oxigenación fetal y aumenta riesgo de parto prematuro.

4.3. Epidemiología

- Chile tiene una de las **tasas de tabaquismo más altas de América Latina**, especialmente en mujeres jóvenes (ENS 2017).
- La prevalencia de consumo diario en adolescentes es del **15 %** (ENJUV 2022).

4.4. Intervenciones ministeriales

a) Ley del Tabaco (Ley N° 19.419 / modificada 2013)

- Prohíbe fumar en espacios cerrados públicos.
- Regula publicidad y etiquetado.
- Prohíbe venta a menores de edad.

b) Estrategia Nacional “Chile Libre de Tabaco”

- Implementa consejerías breves en APS.
- Terapia de cesación con fármacos (bupropión, vareniclina, parches).
- Apoyo telefónico y comunitario.

c) En APS:

- Identificación sistemática de fumadores.
 - Registro en EMPA y control cardiovascular.
 - Consejería motivacional y seguimiento.
-

5. Alcohol

5.1. Relevancia

El consumo nocivo de alcohol causa **daño hepático, trastornos mentales, accidentes de tránsito y violencia**.

En Chile, se asocia a más de **3.500 muertes anuales** (DEIS 2021).

5.2. Epidemiología

- Consumo per cápita: **9,3 litros de alcohol puro/año** (OPS, 2022).
- **11,7 %** de adultos presenta consumo riesgoso (ENS 2017).
- En adolescentes, el **30 %** ha consumido alcohol en el último mes (SENDA 2021).

5.3. Marco normativo

Ley N° 19.925 (Ley de Alcoholes):

- Prohíbe venta a menores.
- Regula publicidad y horarios.
- Endurece sanciones por conducción bajo influencia del alcohol.

Estrategia Nacional de Alcohol y Salud Pública (MINSAL–SENDA 2019):

- Pesquisa mediante test **AUDIT** en APS.
- Consejería breve y derivación a centros de tratamiento.

5.4. Enfoque en APS

- Aplicación del **AUDIT-C** a mayores de 18 años.
 - Consejería breve individual y familiar.
 - Derivación a salud mental o SENDA cuando corresponde.
 - Educación sobre consumo responsable y efectos a largo plazo.
-

6. Obesidad

6.1. Definición

“Acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede perjudicar la salud.”
(OMS, 2021)

6.2. Situación en Chile

- **3 de cada 4 adultos** presentan exceso de peso (ENS 2017).
- **1 de cada 3 niños** de 1° básico tiene obesidad (JUNAEB 2023).
- Chile lidera el ranking OCDE en obesidad infantil.

6.3. Determinantes sociales

- Ambientes obesogénicos: comida ultraprocesada, urbanización sin espacios para actividad física, trabajo sedentario.
- Desigualdades de ingreso y educación.

6.4. Estrategias nacionales

a) Programa Vida Sana (MINSAL)

- Intervención multiprofesional (nutricionista, psicólogo, profesor de educación física).
- Enfocado en sobrepeso, obesidad y riesgo cardiovascular.

b) Ley 20.606 sobre Composición Nutricional y Publicidad de Alimentos (“Ley del Etiquetado”)

- Obliga rotulado frontal con sellos “ALTO EN”.
- Prohíbe venta de alimentos no saludables en colegios.

c) Estrategia Elige Vivir Sano

- Promueve alimentación saludable, actividad física y convivencia familiar.

d) Control y seguimiento en APS

- Evaluación antropométrica en cada ciclo vital.
- Derivación a nutrición y programas Vida Sana o cardiovascular.

7. Sedentarismo

7.1. Definición

“Actividad física insuficiente, es decir, realizar menos de 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de intensa por semana.”
(OMS, 2020)

7.2. Epidemiología

- En Chile, **86,7 %** de la población es sedentaria (ENS 2017).

- Las mujeres presentan mayor sedentarismo (91 %) que los hombres (83 %).
- Solo el **13 %** cumple las recomendaciones de la OMS.

7.3. Consecuencias

- Riesgo aumentado de DM2, obesidad, enfermedad cardiovascular y cáncer.
- Efectos psicológicos: depresión, ansiedad y baja autoestima.

7.4. Intervenciones ministeriales

a) Programa Elige Vivir Sano

- Campañas nacionales y ferias deportivas.
- Fomento de actividad física en espacios públicos.

b) Promoción en APS y colegios

- Talleres de pausas activas y caminatas.
- Educación en hábitos de movilidad saludable.

c) Enfoque comunitario

- Ciclovías, plazas activas, “Cicletadas por la Salud”.

8. Enfoque integral del riesgo cardiovascular

Los factores mencionados (tabaco, alcohol, sedentarismo, obesidad) se integran en el **Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)** del MINSAL.

Objetivos del PSCV

1. Disminuir mortalidad y morbilidad por ECNT.
2. Detectar precozmente hipertensión, DM2, dislipidemias y obesidad.
3. Promover control y adherencia al tratamiento.

Acciones en APS

- Control cardiovascular integral (presión, glicemia, colesterol, IMC).
 - Clasificación de riesgo y seguimiento anual.
 - Consejería individual y grupal.
 - Derivación a nivel secundario cuando sea necesario.
-

9. Enfoque intersectorial y comunitario

El control de los factores de riesgo modificables requiere **acciones intersectoriales**:

Sector	Acción
Educación	Programas de alimentación saludable y educación física.
Municipalidades	Promoción de entornos activos, ferias de salud, ciclovías.
Trabajo	Programas de salud laboral, pausas activas.
Medios de comunicación	Regulación de publicidad de alcohol y tabaco.
Comunidad organizada	Talleres de autocuidado y redes locales.

10. Rol del médico general

Función	Ejemplo práctico
Evaluar riesgos	Aplicar EMPA y clasificar según riesgo cardiovascular.
Educar y motivar	Consejería breve en cada control.
Acompañar cambio conductual	Plan de metas realistas y seguimiento.
Coordinar con otros profesionales	Derivación a nutrición, psicología o kinesioterapia.
Participar en actividades comunitarias	Charlas, caminatas, talleres intersectoriales.

El médico general debe **liderar el enfoque preventivo** y actuar como **modelo de comportamiento saludable** dentro del equipo.

11. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Pensar que la obesidad es solo un problema de voluntad individual	Es multifactorial y determinada socialmente.
Creer que el tabaquismo es un hábito, no una adicción	Es una dependencia fisiológica tratable.
Asumir que el alcohol en “moderación” no causa daño	No existe consumo totalmente seguro.

Subestimar el sedentarismo

Tiene impacto comparable al tabaquismo.

Ignorar la interrelación entre factores

Obesidad, sedentarismo y alcohol se potencian mutuamente.

12. Normativa y programas ministeriales vigentes

- Política Nacional de Promoción de la Salud (MINSAL, 2018)
- Estrategia Nacional de Salud 2021–2030
- Programa Vida Sana (MINSAL)
- Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)
- Ley del Tabaco N° 19.419
- Ley de Alcoholes N° 19.925
- Ley 20.606 del Etiquetado Nutricional
- Programa Elige Vivir Sano (Ley N° 20.670)
- Encuesta Nacional de Salud (ENS 2016–2017)

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **factores de riesgo modificables** (tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo) explican más del 70 % de las ECNT en Chile.
2. El **tabaquismo** sigue siendo la principal causa prevenible de muerte; su abordaje requiere consejería y tratamiento farmacológico.
3. El **consumo nocivo de alcohol** contribuye a enfermedades hepáticas, accidentes y violencia, y se pesquisa con **AUDIT-C** en APS.

4. La **obesidad** tiene origen multifactorial; los programas **Vida Sana** y **Ley del Etiquetado** son estrategias centrales.
5. El **sedentarismo** afecta a casi 9 de cada 10 adultos chilenos y requiere promoción intersectorial del ejercicio.
6. El **médico general** tiene rol clave como educador, pesquisador y promotor del cambio conductual.
7. En el **EUNACOM**, se evalúa la correcta identificación de los factores y su vínculo con estrategias nacionales preventivas.